

Fecha Última Actualización: 12-01-2026 12:44:14

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Patricio Andrés González Valdés
Edad : 41a 2m 20d
Dirección : Cerro Florido 1672

Rut : 15.907.809-4
Fecha Nacto: 23/10/1984
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2113579
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 3588 7245

N° Epicrisis
468357

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 05/01/2026 15:40

Días Estadía: 7

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 12/01/2026 12:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Obstrucción vía aérea con cuerpo extraño

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS UTIM 12/01/2026

Nombre: Patricio Andrés González Valdés
Edad: 41 años
RUT: 15.907.809-4
FI HSR SU: 05/01/2026
FI UPC 06/01/2026
FI UTIM 10/01/2026

ANTECEDENTES

Mórbidos: (-)
Hospitalizaciones recientes: (-)
Medicamentos: (-)
Quirúrgicos: Meniscectomía rodilla izquierda
Alergias: (-)
Hábitos: TBQ (+) 1 cajetilla diaria, OH (+) ocasional 1 lata de cerveza cada 2 semanas Drogas (-)
Social: Trabaja en construcción

ANAMNESIS

Paciente sin antecedentes de relevancia, ingresa al servicio de urgencias trasladado por SAMU al servicio de urgencias de CASR debido a aspiración de cuerpo extraño (papa frita), tras lo cual inicia dificultad respiratoria y sensación de ahogo. Se intenta retirar cuerpo extraño, de forma inefectiva, persistiendo con este. Ingres a al reanimador taquicárdico (135 lpm), taquipneico, normosaturando (93%). Al examen físico destaca agitado, diaforético, sin enfisema subcutáneo, examen pulmonar con murmullo pulmonar (+) bilateral, con sibilancias a izquierda. Por sospecha de cuerpo extraño de vía aérea se decide intubar. Luego de 1 hora intubado despierta y se autoextuba, se apoya con MAF y se reintuba con laringoscopia directa, tubo 9, visualizando sangrado escaso en vía aérea superior. De los exámenes de laboratorio destaca hiperkalemia leve (5.15, muestra hemolizada), elevación de creatinina (1.85), hiperlactatemia (4.3) y leve elevación de parámetros inflamatorios (PCR 11.9). Se realiza TAC tórax, el cual no se observa cuerpo extraño en vía aérea, y se observa parénquima sin condensaciones, motivo por el cual se realiza fibrobroncoscopia que no muestra cuerpo extraño. Ingres a UCI para continuar manejo.

Fecha Epicrisis : 12/01/2026 12:44

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Jueves, 26 de Marzo de 2026 00:14

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 12-01-2026 12:44:14

Página 2 de 4

LABORATORIO DE INGRESO:

05/01/2026 ELP 138/5.15/103 pH 7.27 pCO2 32 HCO3 14.6 Láctico 4.3 Creatinina 1.85 BUN 19.7 PCR 11.9

IMÁGENES DE INGRESO:

05/01 TAC de Tórax: Secreciones hidroaéreas en nasofaringe y orofaringe. Resto del estudio sin hallazgos de significado patológico.

DIAGNÓSTICOS INGRESO

- 1) Insuficiencia respiratoria aguda.
- Obs Cuerpo extraño vía aérea.

EVOLUCIÓN DURANTE SU ESTADIA HOSPITALARIA

1) Hemodinamia: Ingres a UPC con requerimientos de NAD hasta 0.08 ug/kg/min en contexto de sedación, logrando suspensión el 08/01. Evoluciona con tendencia a la hipertensión sistólica con uso de VDO, ARA II con buena respuesta. Se indica seguimiento al alta en APS.

2) Respiratorio: Ingresa en contexto de sospecha cuerpo extraño en vía aérea, con requerimiento de manejo avanzado vía aérea, IOT, con TAC y fibrobroncoscopia que no logran encontrar cuerpo extraño. Evoluciona sin conflicto de intercambio, extubándose el 08/01 saliendo a NRC bien tolerada. Es trasladado a UTIM sin requerimientos de oxígeno. Logra destete de O2 bien tolerado.

3) Infeccioso: Se inicia terapia antibiótica con Ampicilina/Sulbactam. En en UPC evoluciona con parámetros inflamatorios al alza y febril hasta 38°C durante las primeras 48 horas, con CAET que muestra flora comensal. Ante sospecha de neumonía aspirativa, se mantuvo esquema antibiótico, completando 7 días de tratamiento con buena respuesta clínica, descenso progresivo de PPII.

4) Renal: Al ingreso cursa con AKI de probable origen prerrenal. Se instala sonda Foley, y al retirar presenta hematuria macroscópica, que resuelve espontáneamente. Evoluciona con mejoría función rena, normalización creatinina previo al alt (0.78).

5) Psiquiátrico: Al ingreso se describe policonsumo (OH y THC), cursa con episodios de agitación por lo que se inició manejo con antipsicóticos y carga de tiamina. Una vez extubado se interroga nuevamente descartando consumo problemático. Dado buena evolución clínica, se suspende uso de haloperidol y olanzapina. Se sugiere ingreso a programa salud mental en APS de form ambulatoria por seguimiento.

6) Metabólico: Inicialmente en régimen cero, luego se inicia nutrición enteral por SNG. Mantuvo seguimiento por fonaudiología, progresando en regimen sin mayor conflicto. Se retira SNG sin incidentes y logra regimen común bien tolerado.

7) Profilaxis: Mantuvo profilaxis con IBP y HBPM.

ULTIMO LABORATORIO

12/01: Lactato 1.3 Alb 3.5, Crea 0.78, BUN 11.3 P 3.4 PCR 25.7 (43), Hb 14.7 VCM 85.5 GB 5610 Pq 385000 ELP 141/3.79/105 pH .39 HCO3 28 INR 1.26 TTPK 32.9

IMAGENES

05/01 TAC de Cuello y Tórax: Secreciones hidroaéreas en nasofaringe y orofaringe. Resto del estudio sin hallazgos de significado patológico.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

1. OVACE (Obstrucción vía aérea por cuerpo extraño)
- IOT/VMI 05/01 - 08/01
- Sospecha neumonía aspirativa tratada
- Hematuria macroscópica Obs traumática resuelta
- AKI KDIGO 1 Obs pre-renal resuelta

Fecha Epicrisis : 12/01/2026 12:44

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 12-01-2026 12:44:14

Página 3 de 4

-Hipertensión Arterial

INDICACIONES DE ALTA

MEDIDAS GENERALES

Regimen común hiposódico

Reposo relativo , retomar actividades de forma gradual

MEDICAMENTOS

Losartán 50 mg cada 12 horas VO

Paracetamol 500mg , 2 comprimidos cada 8 horas SOS si dolor (máxim cada 8 horas)

CONTROLES

Ingreso a Programa Cardiovascular APS (Consultorio), para seguimiento por diagnóstico de HTA y ajuste de terapia antihipertensiva

Se sugiere evaluación en Programa Salud Mental APS (Consultorio), en conetxto de uso de sustancias

Acudir al SU en caso de signos y síntomas de alarma SOS

Diagnóstico de Egreso

CUERPO EXTRANO EN LAS VIAS RESPIRATORIAS -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en buenas condiciones generales, con hemodinamia estable, sin requerimientos de O2 Asintomático. Con parámetros inflamatorios en descenso progresivo, sin nuevas interurrencias. Completa tratamiento antibiótico con buen respuesta.

Plan Post Alta

INDICACIONES DE ALTA

MEDIDAS GENERALES

Regimen común hiposódico

Reposo relativo , retomar actividades de forma gradual

MEDICAMENTOS

Losartán 50 mg cada 12 horas VO

Paracetamol 500mg , 2 comprimidos cada 8 horas SOS si dolor (máxim cada 8 horas)

CONTROLES

Ingreso a Programa Cardiovascular APS (Consultorio), para seguimiento por diagnóstico de HTA y ajuste de terapia antihipertensiva

Se sugiere evaluación en Programa Salud Mental APS (Consultorio), en conetxto de uso de sustancias

Acudir al SU en caso de signos y síntomas de alarma SOS

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 12/01/2026 12:44

Página 3 de 4

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 12-01-2026 12:44:14

Página 4 de 4

INTERNO



Vania Fernanda Bec Cari Gormaz
Becado/Residente



Maria Alejandra Cartes Lagos
Médico Tratante (Staff)